

Ein autistischer Teenager / eine autistische Teenagerin in Ihrer Praxis

Für Hausärzt:innen, Pflegekräfte und Psychotherapeut:innen — Versorgung einer autistischen Adolescentin / eines Adoleszenten (etwa 12–18 Jahre).

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit eines Teenagers in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Pubertät und Adoleszenz häufen vielspurige Anforderungen — wechselnde Peer-Regeln, Identität, Daten, Körperveränderungen — auf ein System, das schnelles Wechseln als kostenintensiv empfindet. Dies ist das **Spitzenalter für Angst, Depression und Burnout**, und viele autistische Teenager (besonders Mädchen und marginalisierte Geschlechter) werden **erst in der Krise erkannt**. Behandeln Sie die junge Person als Expertin bzw. Experten für ihr eigenes Erleben.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Erschöpft, zurückgezogen, „keine Lust“; verweigert die Schule	Wahrscheinlich autistisches Burnout oder Überlastung — von Depression und von Faulheit zu unterscheiden
Selbstverletzung, Suizidgedanken oder Krisen-Präsentation	Reales, erhöhtes Risiko in dieser Gruppe; oft das erste Zeichen unerfüllten Bedarfs
Intensive, verzehrende Interessen; wehrt sich, sie aufzugeben	Interessen sind Identität, Regulation und Erholung — keine zu begrenzenden Zwänge
Im Termin „gut“, bricht danach zusammen	Starkes Camouflaging ; die Kosten werden später gezahlt
Braucht schriftlichen Kontakt, meidet Blickkontakt, lange Pausen	Eingekanalige Kommunikation + Verarbeitungszeit, keine Unhöflichkeit

Versuchen Sie dies

- **Bieten Sie das AASPIRE AHAT** vorab und eine **schriftliche oder Online-Termoption**; viele Teenager kommunizieren schriftlich deutlich besser.
- **Fragen Sie direkt und getrennt** nach Stimmung, Angst, Burnout, Schlaf, Essen und Suizidgedanken — mit konkreten, wörtlichen Fragen.
- **Validieren Sie ihre Interessen** als legitim; fragen Sie, was sie lieben, und schützen Sie den Zugang dazu.
- **Gewähren Sie Verarbeitungszeit**; bieten Sie an, danach eine schriftliche Zusammenfassung zu schicken.
- **Beziehen Sie sie in Entscheidungen ein** und achten Sie die Autonomie; bauen Sie eine vorhersagbare, sensorisch arme Routine für Folgebesuche auf.

Vermeiden Sie dies

- **Autistisches Burnout mit Depression verwechseln** — es als Depression (oder „strenge dich an“) zu behandeln, kann es vertiefen und das Suizidrisiko erhöhen.
- Den Teenager zum Masken, Blickkontakt oder „sei geselliger“ als Ziel drängen.

- Annehmen, eine langsame oder ungewöhnliche Antwort bedeute, sie verstehe nicht oder fehle die Kapazität.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Screenen Sie direkt auf Suizidalität — autistische Teenager sind erhöhtem Risiko ausgesetzt. Unterscheiden Sie **autistisches Burnout** (Erschöpfung + Kompetenzverlust + verminderte Reiztoleranz; braucht *reduzierte Anforderungen, Akzeptanz und Erlaubnis zu entmasken*) von Depression. Behandeln Sie pubertätsbedingte sensorische und praktische Bedürfnisse (Menstruation, Hygiene) konkret. Planen Sie den **Übergang zu Erwachsenenendiensten früh**, mit den Interessen der jungen Person im Zentrum. Verweisen Sie an autistische Peer-Gruppen und Mentor:innen — hochwertige Freundschaft ist stark schützend.

Wenn der Teenager ein Mädchen oder ein marginalisiertes Geschlecht ist

Camouflaging gipfelt hier und treibt viel der verpassten Diagnose und psychischen Kosten. Das Erscheinungsbild kann wie „ängstlich, perfektionistisch, oberflächlich sozial kompetent“ wirken. Fragen Sie gezielt nach **Masking-Erschöpfung** und internalisierenden Symptomen.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — das **Monotropismus**-Dossier und der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.3 & 4). Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an die einzelne Person an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, Burnout); Pearson & Rose (2021, Masking); Bradley et al. (2021, Camouflaging); AASPIRE AHAT; Autism Awareness Australia (Teenager-Psyché). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.